

1. ชื่อผลงาน : “เสริมสร้างพลังใจในภาวะวิกฤต”

2. ผลงานประเภท : CQI

3. คำสำคัญ : การเสริมสร้างพลังใจ, ทักษะการฟื้นคืน (Resilience)

4. สรุปผลงานโดยย่อ

บ้านพักพิงเพื่อครอบครัวผู้ป่วยเด็ก ให้บริการที่พักรักษาตัวแก่ครอบครัวของผู้ป่วยเด็กที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล เพื่อให้ครอบครัวได้อยู่พร้อมหน้าในยามวิกฤตเมื่อลูกป่วยหนัก โดยเฉพาะผู้ปกครองของผู้ป่วยเด็กในหอผู้ป่วยวิกฤต (PICU) ซึ่งต้องเผชิญภาวะวิกฤตจากการเจ็บป่วยของบุตร ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจ ได้แก่ ความเครียด ความกลัว ความวิตกกังวล และความรู้สึกผิดเกี่ยวกับการรักษาและความทุกข์ทรมานของเด็ก อีกทั้งยังพบปัญหาด้านสังคม เช่น การขาดความรู้เกี่ยวกับแหล่งเครือข่ายทางสังคมและระบบการช่วยเหลือที่เหมาะสม

ทักษะการฟื้นคืน (Resilience) เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้บุคคลสามารถปรับตัว เผชิญ และจัดการกับปัญหาได้อย่างเหมาะสม ดังนั้นจึงได้พัฒนากิจกรรม “เสริมสร้างพลังใจในภาวะวิกฤต” เพื่อให้ความรู้และทักษะด้าน Resilience และแหล่งเครือข่ายสวัสดิการสังคมแก่ผู้ปกครอง ณ บ้านพักพิงเพื่อครอบครัวผู้ป่วยเด็ก โดยจัดกิจกรรมในวันศุกร์ที่ 1 และ 2 ของทุกเดือน

ดำเนินกิจกรรมระหว่างเดือนมีนาคม-กรกฎาคม 2569 จำนวน 8 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวม 48 คน ผลการประเมินความพึงพอใจภายหลังเข้าร่วมกิจกรรม พบว่า ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจเฉลี่ย ร้อยละ 93.75 (4.69 คะแนนจาก 5 คะแนน) สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ ร้อยละ 75 และผู้เข้าร่วม ร้อยละ 100 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีผู้ให้คะแนนระดับมากที่สุด 31 คน และระดับมาก 17 คน สะท้อนว่ากิจกรรมสามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้เข้าร่วมได้ตามเป้าหมาย

ข้อมูลเชิงคุณภาพจากคำตอบปลายเปิดของผู้เข้าร่วม พบว่า ผู้เข้าร่วมสามารถสะท้อนความรู้และแนวทางการนำทักษะการฟื้นคืน (Resilience) ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งด้านการดูแลกายและใจ เช่น การฝึกกำหนดลมหายใจ การฝึกหายใจ การกอดตัวเองเพื่อฟื้นคืนพลังใจ การออกกำลังกาย การดูแลตนเอง ตลอดจนการตระหนักถึงความสำคัญของความสัมพันธ์และการมี “ทีมชีวิต” และทราบแหล่งเครือข่ายสวัสดิการสังคม เพื่อสนับสนุนในการดำเนินชีวิต

5. เป้าหมายและวัตถุประสงค์

เป้าหมาย

- 1) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้เกี่ยวกับทักษะการฟื้นคืน (Resilience) และแหล่งเครือข่ายสวัสดิการสังคมเพิ่มขึ้นหลังเข้าร่วมกิจกรรม
- 2) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะการฟื้นคืน (Resilience) และแหล่งเครือข่ายสวัสดิการสังคมแก่ผู้ปกครอง
- 2) เพื่อให้ผู้ปกครองนำความรู้และทักษะไปใช้ได้อย่างเหมาะสม

6. ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ :

การเจ็บป่วยของเด็กและการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล โดยเฉพาะในหอผู้ป่วยวิกฤต เป็นภาวะวิกฤตที่ส่งผลกระทบต่อครอบครัวอย่างมาก ผู้ปกครองต้องเผชิญกับความเครียด ความวิตกกังวล ความกลัว และความไม่แน่นอนเกี่ยวกับอาการและผลการรักษาของบุตร

บ้านพักพิงเพื่อครอบครัวผู้ป่วยเด็กเป็นบริการที่พักรักษาตัวสำหรับครอบครัวของผู้ป่วยเด็กที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนให้ครอบครัวสามารถอยู่ใกล้ชิดและดูแลเด็กได้อย่างต่อเนื่องในช่วงภาวะวิกฤต โดยเฉพาะผู้ปกครองของผู้ป่วยเด็กในหอผู้ป่วยวิกฤต ซึ่งต้องเผชิญกับความเครียดและภาระทางจิตใจอย่างต่อเนื่อง

¹จากการศึกษาพบว่าผู้ปกครองมีระดับความเครียดสูงจากหลายปัจจัย ได้แก่ การรอคอยในโรงพยาบาล การทำหัตถการที่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดต่อเด็ก สภาพแวดล้อมในโรงพยาบาล และความรุนแรงของโรคของเด็ก รวมทั้งอารมณ์ของผู้ปกครองเองก็มีผลต่อความเครียด นอกจากนี้ปัญหาด้านจิตใจแล้ว ผู้ปกครองยังอาจประสบปัญหาด้านสังคม เช่น การขาดความรู้เกี่ยวกับแหล่งสนับสนุนทางสังคม เครือข่ายความช่วยเหลือ และระบบสวัสดิการที่เหมาะสม ส่งผลให้ไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากรช่วยเหลือได้อย่างทันที่ และเพิ่มภาระความเครียดในช่วงการดูแลเด็กที่เจ็บป่วยวิกฤต

ในทางกลับกัน ²ทักษะการฟื้นคืน (Resilience) เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ผู้ปกครองสามารถปรับตัวและเผชิญกับสถานการณ์วิกฤตได้อย่างเหมาะสม ดังนั้น การส่งเสริมทักษะการฟื้นคืนควบคู่กับการสนับสนุนทางสังคมจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในบริบทของบ้านพักพิงเพื่อครอบครัวผู้ป่วยเด็ก ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เอื้อต่อการดูแลและสนับสนุนครอบครัวในช่วงภาวะวิกฤต ด้วยเหตุนี้ กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์จึงได้พัฒนากิจกรรม“เสริมสร้างพลังใจในภาวะวิกฤต” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะการฟื้นคืน (Resilience) และการเข้าถึงแหล่งเครือข่ายสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ปกครอง ณ บ้านพักพิงเพื่อครอบครัวผู้ป่วยเด็ก โดยจัดกิจกรรมในวันศุกร์ที่ 1 และ 2 ของทุกเดือน

7. กิจกรรมการพัฒนา :

- 1) วิเคราะห์ปัญหาของผู้ปกครองผู้ป่วยเด็กในภาวะวิกฤตและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์มีบทบาทในการดูแลผู้ป่วยเด็กและครอบครัว ทั้งด้านการประเมินปัญหาทางจิตสังคม การให้คำปรึกษา การประสานทรัพยากรช่วยเหลือ และการส่งเสริมศักยภาพครอบครัวในการเผชิญภาวะวิกฤต จึงได้พัฒนากิจกรรม “เสริมสร้างพลังใจในภาวะวิกฤต”
- 2) ศึกษาและเข้าร่วมอบรมด้านทักษะการฟื้นคืน (Resilience)
- 3) ออกแบบชุดกิจกรรม “เสริมสร้างพลังใจในภาวะวิกฤต” โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็นหมวดทักษะที่ส่งเสริมการฟื้นคืน (Resilience) ครอบคลุมการดูแลและจัดการอารมณ์ การจัดการความคิด การผ่อนคลายและดูแลตนเอง การเผชิญและจัดการปัญหา ตลอดจนการค้นหาแหล่งสนับสนุนทางสังคมและแหล่งเครือข่ายสวัสดิการ โดยในการดำเนินกิจกรรมแต่ละครั้งคัดเลือกกิจกรรมจำนวน 2 หมวด สลับหมุนเวียนให้เหมาะสมกับบริบทและผู้เข้าร่วมกิจกรรม
- 4) คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย (ผู้ปกครองที่พักในบ้านพักพิงเพื่อครอบครัวผู้ป่วยเด็ก)
- 5) ประสานศูนย์ Child Friendly Hospital เพื่อขอใช้พื้นที่ในการดำเนินกิจกรรม
- 6) ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้ปกครองที่พักอาศัยในบ้านพักพิงเพื่อครอบครัวผู้ป่วยเด็กเข้าร่วมกิจกรรม ผ่านเจ้าหน้าที่ สื่อประชาสัมพันธ์ และการเชิญชวนรายกลุ่ม

¹ Zdon-Ryżewska A, et al. Parent's stress predictors during a child's hospitalization. Int J Environ Res Public Health. 2021.

Boonchooduang N, et al. Parental resilience and child QoL following paediatric hospitalisation. BMJ Paediatr Open. 2025.

Alzawad Z, et al. Parental stress during children's hospitalisation in PICU. Intensive Crit Care Nurs.

Canga M, et al. Stressors among parents with hospitalized children. J Educ Health Promot. 2020.

² Luo Y, Li HCW, Xia W, Cheung AT, Ho LLK, Chung JOK. 2022. The Lived Experience of Resilience in Parents of Children With Cancer: A Phenomenological Study. Front Pediatr. 10:871435.

7) ดำเนินกิจกรรม “เสริมสร้างพลังใจในภาวะวิกฤต” ใช้เวลา 45 นาที/ครั้ง ในวันศุกร์ที่ 1 และ 2 ของทุกเดือน

8) ประเมินและสรุปผลก่อน-หลังการเข้าร่วมกิจกรรม

8. ตัวชี้วัดความสำเร็จที่สำคัญ :

- 1) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้และทักษะการฟื้นคืน (Resilience) และแหล่งเครือข่ายสวัสดิการสังคม
- 2) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจร้อยละ 75

9. การประเมินผลการเปลี่ยนแปลงและผลลัพธ์

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	ผลผลิต (Output)	ผลลัพธ์ (Outcome)
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้และทักษะการฟื้นคืน (Resilience) และแหล่งเครือข่ายสวัสดิการสังคม	1. ผู้เข้าร่วมได้รับกิจกรรมเสริมทักษะด้าน Resilience และการเข้าถึงเครือข่ายสวัสดิการสังคม	1. ข้อมูลเชิงคุณภาพจากคำตอบปลายเปิด ผู้เข้าร่วมสามารถสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้ และแนวทางการนำทักษะ Resilience ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น การฝึกกำหนดลมหายใจ การดูแลตนเอง การฟื้นคืนพลังใจ และการออกกำลังกาย 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกรายทราบแหล่งเครือข่ายสวัสดิการทางสังคม 3. ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจต่อกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 และอยู่ในระดับมาก-มากที่สุด
4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	2. มีการจัดกิจกรรมตามแผนและมีแบบประเมินความพึงพอใจหลังเข้าร่วมกิจกรรม	

10. บทเรียนที่ได้รับ

ปัญหาและวิธีการจัดการกับความท้าทาย	ข้อเสนอแนะ	สิ่งที่จะทำแตกต่างจากเดิม
● ปัญหา : ขณะทำกิจกรรมมีผู้ร่วมกิจกรรมเพิ่ม ส่งผลต่อความต่อเนื่องในการทำกิจกรรม ● การจัดการ : สรุปประเด็นสำคัญเป็นระยะ	● ควรจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการฟื้นคืน (Resilience) ของผู้ปกครอง ● ควรพัฒนาสื่อสนับสนุนความรู้ เช่น แผ่นพับ หรือ QR code ทักษะ Resilience เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถนำไปใช้ทบทวนและฝึกทักษะได้ด้วยตนเอง	● ปรับเพิ่มจำนวนวันในการจัดกิจกรรม เพื่อให้สามารถรองรับผู้เข้าร่วมที่เพิ่มขึ้น

11. ข้อมูลการติดต่อประสานงาน

ที่ปรึกษา :

- นางสาววรรณ ไชยมูล สส.ม. หัวหน้ากลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์

ผู้รับผิดชอบ :

- นางสาวกรรณิกา คงหนองลาน สส.บ. นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ
- นางสาวสุภาวดี บุญรอด สส.บ. นักสังคมสงเคราะห์
- นางสาวมณฑิตา บัวสุวรรณ สส.บ. นักสังคมสงเคราะห์

กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ โทรศัพท์ 3327 E-mail : swqsnich@gmail.com

แบบประเมินตนเองในการส่งผลงานเข้าร่วมงานมหกรรมคุณภาพ (Self Check)

โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่ตรงกับผลงาน

ชื่อผลงาน “เสริมสร้างพลังใจในภาวะวิกฤต”

หน่วยงาน.....กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์.....โทร.....3327.....

หมวดหมู่ของผลงานการพัฒนาคุณภาพ.....CQI.....

☐ เคยส่งผลงานเรื่องนี้เข้าร่วมงาน ☒ ยังไม่เคยส่งผลงานเรื่องนี้เข้าร่วมงาน

ลำดับที่	รายการ	คะแนนประเมินตนเอง				
		1 คะแนน	2 คะแนน	3 คะแนน	4 คะแนน	5 คะแนน
1	ระดับความสำเร็จของผลงาน	☐ อยู่ในกระบวนการคิด	☐ กำลังดำเนินการ	☐ ต่อยอดจากของเดิม	☒ สำเร็จแล้ว	☐ มีการขยายผลไปหน่วยงานอื่น
2	รูปแบบการทำกิจกรรม	☐ ยังไม่ชัดเจน	☐ พัฒนาจากแนวทางที่มีอยู่แล้ว	☐ ทดลองทำขึ้นใหม่	☒ มีลักษณะของ PDCA/KM/R2Rชัดเจน	☐ ยังไม่มีการทำมาก่อนในประเทศไทย
3	ผลลัพธ์ของการพัฒนา	☐ ยังไม่ชัดเจน	☐ มีความชัดเจน	☒ ใช้ประโยชน์ได้ดี	☐ ประหยัดทรัพยากร	☐ ขยายผลไปยังหน่วยงานอื่น/หรือภายนอก
4	ความร่วมมือต่อการนำผลงานไปใช้	☐ คนเดียว	☒ วิชาชีพเดียว	☐ 2 วิชาชีพ	☐ ทีมสหสาขาภายในหน่วยงาน	☐ เป็นทีมสหสาขาระหว่างหน่วยงาน
5	ผลกระทบของการพัฒนา	☐ ใช้ในหน่วยงาน	☒ ใช้ร่วมกับหน่วยงานอื่น	☐ ใช้ร่วมกับนอกสถาบัน	☐ สามารถเปรียบเทียบกับภายนอกได้	☐ ได้รับรางวัลระดับประเทศ

รวมคะแนน

15

